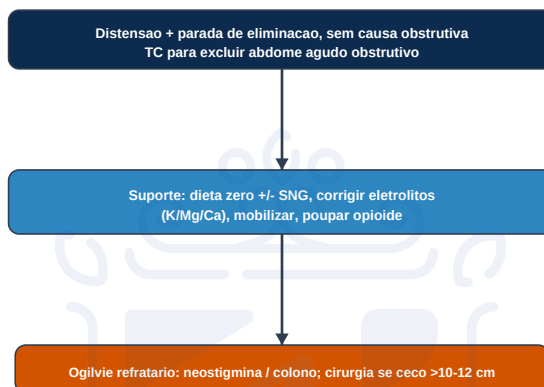


ÍLEO PARALÍTICO — SUPORTE + ELETRÓLITOS

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

ÍLEO PARALÍTICO — EXCLUIR OBSTRUÇÃO -> SUPORTE



DEFINIÇÃO E DIAGNÓSTICO

O QUE É

- Íleo adinâmico: parada funcional da motilidade intestinal SEM obstrução mecânica
- Fatores: pós-operatório abdominal, paciente de UTI, restrição ao leito, distúrbios eletrolíticos, opioides
- Clínica: distensão abdominal, parada de eliminação de fezes e flatos; toque retal com fezes em ampola
- Diagnóstico CLÍNICO; TC de abdome para EXCLUIR obstrução mecânica (abdome agudo obstrutivo)
- Sinais de alarme: febre, peritonite, piora clínica geral (reavaliar diagnóstico)

MEDIDAS DE SUPORTE

Rx PILAR DO TRATAMENTO

Dieta zero (NPO); SNG para descompressão se vômitos persistentes/distensão importante
Corrigir distúrbios hidroeletrólíticos: potássio 4-5,5 mEq/L, magnésio > 2 mg/dL, cálcio normal
MOBILIZAÇÃO precoce (deambular) para estimular o peristaltismo
Balanço hídrico restritivo (evitar sobrecarga e edema de alças)
Tratar a causa de base

MANEJO FARMACOLÓGICO (ERAS)

Rx PROCINÉTICOS E AJUSTES

POUPAR OPIOIDES (retardam a motilidade): preferir AINE ou analgesia epidural
Procinéticos: Metoclopramida ou Domperidona; Bromoprida (estimula a peristalse); eritromicina em casos refratários
EVITAR ondansetrona (reduz a motilidade GI) — preferir bromoprida como antiemético
Goma de mascar (sham feeding): estimula o reflexo cefálico-vagal (ERAS)
Alimentação enteral precoce conforme tolerância (líquida -> leve)

SÍNDROME DE OGILVIE (PSEUDO-OBSTRUÇÃO COLÔNICA)

ESCALONAMENTO

- Pseudo-obstrução colônica aguda por hiperestímulo simpático: TRM, imobilidade, politrauma, narcóticos, distúrbios metabólicos, doença neurodegenerativa
- Achado: dilatação do cólon SEM obstrução mecânica
- 1º) tratamento CLÍNICO (mesmas medidas do íleo: suporte, eletrólitos, suspender opioides, mobilizar)
- 2º) NEOSTIGMINA (sob monitorização cardíaca) ou colonoscopia descompressiva
- 3º) CIRURGIA se refratário e CECO > 10-12 cm (risco iminente de perfuração) — cecostomia/colectomia

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ (PON / UTI / restrito ao leito) com distensão + parada de eliminação; obstrução mecânica EXCLUÍDA (TC): ____.
- Eletrólitos: K ____, Mg ____, Ca ____; opioides em uso ____; sinais de alarme (febre/peritonite) ____.
- Conduta: dieta zero ± SNG, correção eletrolítica, mobilização, procinético, poupar opioide.
- Ogilvie/refratário: neostigmina/colono; solicito cirurgia se ceco > 10-12 cm ou refratariedade.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é a base do tratamento do íleo paralítico pós-operatório?

- A) Cirurgia imediata
- B) Medidas de suporte: dieta zero $\pm$ SNG, correção de eletrólitos, mobilização e poupar opioides
- C) Antibiótico de amplo espectro
- D) Laxativos potentes via oral
- E) Ondansetrona em dose alta

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual distúrbio eletrolítico deve ser corrigido prioritariamente no íleo paralítico?

- A) Hipernatremia
- B) Hipopotassemia (manter K 4-5,5 mEq/L), além de magnésio e cálcio
- C) Hiperclorêmia
- D) Hiperfosfatemia
- E) Hipozincemia

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual antiemético deve ser EVITADO no íleo paralítico por reduzir a motilidade?

- A) Bromoprida
- B) Ondansetrona
- C) Metoclopramida
- D) Domperidona
- E) Eritromicina

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Na síndrome de Ogilvie refratária ao tratamento clínico, qual a próxima medida?

- A) Cirurgia imediata em todos
- B) Neostigmina (com monitorização cardíaca) ou colonoscopia descompressiva
- C) Apenas observação prolongada
- D) Laxante osmótico
- E) Antibiótico

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Na síndrome de Ogilvie, qual diâmetro cecal indica risco iminente de perfuração e considera cirurgia?

- A) > 4 cm
- B) > 10-12 cm
- C) > 6 cm
- D) > 2 cm
- E) Qualquer dilatação

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

O íleo paralítico é tratado com medidas de suporte: dieta zero $\pm$ SNG, correção de eletrólitos, mobilização precoce e redução de opioides; a cirurgia não é o tratamento do íleo adinâmico simples.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A hipopotassemia deve ser corrigida prioritariamente (alvo 4-5,5 mEq/L), assim como magnésio (> 2 mg/dL) e cálcio, pois os distúrbios eletrolíticos perpetuam o íleo.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A ondansetrona deve ser evitada por reduzir a motilidade GI; prefere-se a bromoprida (procinética) como antiemético no íleo paralítico.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Na síndrome de Ogilvie refratária ao tratamento clínico, escalona-se para neostigmina (sob monitorização cardíaca) ou colonoscopia descompressiva.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Ceco > 10 -12 cm na síndrome de Ogilvie indica risco iminente de perfuração, sendo critério para cirurgia (cecostomia/colectomia) quando refratário.

SM24
Suporte ao Plantão Médico